
=====

1-les urgences médicales hospitalières de base faisant partie du Réseau Intégré des Soins d'Urgences Médicales assurant les fonctions d'urgence suivantes:

- A. L hospitalisation
- B. Les gestes de réanimation
- C. Le diagnostic de détresse vitale
- D. La transfusion

REP:ABCD

2-les urgences médico-hospitalières complètes sont assurées par :

- A. Les Centres hospitaliers préfectoraux
- B. Les Centres hospitaliers provinciaux
- C. Les Centres hospitaliers régionaux
- D. Les Centres hospitaliers interrégionaux

REP:CD

3-La commission nationale de l'offre de soins

- A. Pour mission de donner son avis sur la carte sanitaire
- B. Estprésidéeparlewalidelarégion
- C. Comprend parmi ses membres un représentantduhautcommissariatauplan
- D. Touteslespropositionsprécédentessontjustes

REP:AC

4-l'évaluation qualitative est une analyse de la qualité d'un acte de soins et de ses:

- A. Conséquences en termes de résultats et de satisfaction des patients
- B. Conséquences en termes de ressources consommées par le soin
- C. Conséquences en termes de recettes engendrées par le soin
- D. Conséquences en termes d'efficacité du soin

REP:AD

5- Un réseau coordonné de soins

- A. Est une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients
- B. La prise en charge se fait au sein du même territoire
- C. Vise le renforcement de la coordination d'une prise en charge médicale multidisciplinaire
- D. Est une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients

REP:BC

6- un centre de santé rural du 2ème niveauoffre

- A. Les soins de consultation de médecine générale
- B. Les soins de consultation de gynécologie
- C. Les examens d'échographie obstétricale
- D. Les soins obstétricaux d'urgence de base

REP:ACD

7- Les hôpitaux sont classés par catégorie selon :

- A. La capacité d'accueil
- B. le niveau d intervention
- C. Le mode de gestion ou statut
- D. L'orientation technique ou spécialisée

REP:ABCD

A- les personnes qui ne sont assujetties a aucun régime d'assurance maladie obligatoire de base et ne disposant pas de ressources suffisantes

E- Les enfants qui vivent sous le même toit que les personnes bénéficiaires

REP:ABDE

.....

4- Critères d'éligibilité AU RAMED EN Milieu urbain

A- Disposer d'un revenu annuel inférieur à 5650 DH/Personnecomposant le ménage

B- Avoir un score des conditions socio-économiques = 11.

C- AVOIR UN Seuil de vulnérabilité = 5650 DH

D- AVOIR UN Seuil de pauvreté = 3767 DH

REP:ABCD

.....

5- Critères d'éligibilité AU RAMED EN Milieu rural

A- Avoir un score patrimonial = 70 par personne composant le ménage;

B- Avoir un score des conditions socioéconomiques = 5

C- AVOIR UN Seuil de vulnérabilité = 70

D- AVOIR UN Seuil de pauvreté >28

REP:AC

.....

6- Panier de soins pour un ramediste

A- Panier de soins hospitalier disponible

B- Rétablissement de la filière de soins sans passer par le centre de santé du lieu de résidence

C- Maintien de la gratuité des soins au niveau du réseau des soins de santé de base

D- toutes les prestations du RAMED sont dispensées uniquement dans les hôpitaux publics-privé, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat

REP:AC

.....

7- Financement du RAMED

A- L'Etat

B- Collectivités Locales

C- Personnes en situation de vulnérabilité

D- Personnes en situation de pauvreté

REP:ABC

.....

8- Au moment du dépôt du formulaire de demande du bénéfice du régime d'assistance médicale ,le postulant reçoit un récépissé

A- Celui-ci confère au postulant la qualité d'éligible au régime d'assistance médicale.

B- permet à son détenteur l'accès aux soins RESSP ET RH.

C- La durée de validité de ce récépissé est de trois (3) mois au plus

D- aucune réponse

REP:C

.....

9- Durée d'admission et de validité de la carte RAMED pour Les personnes en situation de vulnérabilité

A- La durée d'admission est de 1 ans

B- La durée de validité de la carte est d'un an

C- Le renouvellement de la carte se fait à l'expiration de chaque année par le paiement d'une contribution partielle annuelle fixée à 120 DH par personne/an dans la limite d'un plafond de 600 DH par ménage quel que soit l'effectif des personnes le composant

REP:BC

.....
10- Durée d'admission et de validité de la carte RAMED pour Les personnes en situation de pauvreté

A- La durée d'admission est de 1 ans

B- Aucune contribution n'est exigée

C- La durée de validité de la carte est de 3 ans

REP:BC

@@
@@
@@

Q1. La CMB est composée de

A-AMO

B-AMI

C-RAMED

D-AME

REP:AC

.....
Q2. lancement de l'expérience pilote du RAMED;

A-04 novembre 2005

B-04 novembre 2007

C-04 novembre 2008

REP:C

.....
Q3. lancement de la Généralisation du RAMED

A-13 mars 2011

B-13 mars 2012

C-13 mars 2013

REP:B

.....
Q4. Adoption par le parlement de la loi 98-15
pour la couverture médicale des travailleurs non salariés

A-Juin 2015

B-Juin 2016

C-Juin 2017

REP:C

.....
Q5. le pourcentage des bénéficiaires AMO en 2005

A-32%

B-34

C-36

D-aucune réponse

REP:D

.....
Q6. le pourcentage des bénéficiaires RAMED 2012

A-28%

B-25

C-26

REP:A

.....
Q7. le pourcentage des bénéficiaires AMI 2017

A-30%

B-31

REP:C

Q8. LES bénéficiaires de l AMO:

A-Salariés,
B-Fonctionnaires,
C-Retraités,
D-Etudiants

REP:ABCD

Q9. LES bénéficiaires de RAMED

A-Pauvres et vulnérables non couverts par AMO

B-sans domicile
c-les pupilles de la Nation
REP:ABC

Q10. les organismes gestionnaires de l AMI

A-CNOPS
B-ANAM
C-CNSS
REP-C

[illegible]

Q1. Le RISUM a pour mission de Permettre aux malades, une assistance médicale urgente, soit par

A. 1 hospitalisation
B. le conseil,
C. l'orientation vers la structure sanitaire adaptée
D. prise en charge médicale adéquate
REP:BC

Q2. RISUM accomplit sa mission selon

A. trois modes
B. quatre modes
C. cinq modes
D. six modes
REP:A

Q3. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale accomplit sa mission selon les modes suivants

A. les Urgences Médicales de Proximité
B. les Urgences Pré-hospitalières
C. les Urgences médico-hospitalières
D. les Urgences intra-hospitalières
REP:ABC

Q4. les Urgences médico-hospitalières comprennent

A. les urgences médico hospitalières de proximité
B. les urgences médico hospitalières de base
C. les urgences médico-hospitalières complètes
D. les urgences médico-hospitalières spécialisées
REP:BCD

.....

REP:A

.....
3- Parmi les organismes gestionnaires de la couverture Médicale on trouve

- A. L'ANAM.
 - B. RAMED
 - C. La CNSS.
 - D. CNOPS
- REP:ACD

.....
4- Les territoires de santé sont au nombre de :

- A. 2 territoires
- B. 4 territoires.
- C. 6 territoires,
- D. 8 territoines

REP:B

.....
5- Dans le cadre du programme < khadamati> le service (ALLO SAMU > répond au numéro :

- A.141
- B. 15
- C. 0801000180.
- D. 111

REP:A

.....
6- . Installation de santé désigne :

- A. Le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle.
- B. Un Hôpital.
- C. Un centre de santé.
- D. ambulance
- E. equipe mobile
- F. VAD

REP:ABCDEF

.....
7- Etablissements médico-sociaux :

des établissements de santé destinés à des catégories de populations vulnérables qui ont besoin d'un suivi médical régulier

- A. VRAI
- B. FAUX

REP:A

.....
8- S o i n s essentiels ;

- A. Ils comprennent les soins de santé primaires curatifs et les principaux soins de recours hospitaliers de proximité
- B. Ils comprennent les soins de santé primaires et les principaux soins de recours hospitaliers de proximité et les soins de rheabilitations
- C. Ils comprennent les soins de santé primaires et les principaux soins de recours hospitaliers de proximité

REP:C

.....
9- Prestations d'hôpital de jour ;

Prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée, avec ou sans hébergement, si l'étatde santé du patient le permet.

- A. VRAI
- B. FAUX

REP:B

.....
10- Le SROS un moyen de correction des inégalités en santé

A. VRAI

B. FAUX

REP:B

@@
@@
@@

1- Le schéma régional de l'offre de soins (SROS) doit préciser sur la base de la carte sanitaire et des caractéristiques de la région sanitaire concernée

A. Les prévisions relatives au nombre et aux lieux d'implantation

B. Les prévisions relatives aux besoins en ressources humaines et leur réparation

C. Les prévisions relatives aux besoins en équipements biomédicaux lourd et leur réparation

D. Le projet d'établissement au niveau de chaque hôpital

REP:ABC

.....
2- Pour la création et l'implantation d'un centre hospitalier régional ce dernier :

A. Doit desservir au moins quatre régions sanitaires

B. Doit couvrir une population minimale de 200 000 habitants

C. Doit couvrir une population minimale de 70 000 habitants

D. Toutes les propositions précédentes sont fausses

REP:D

.....
3-le plan stratégique régional est document d'orientation des actions sanitaires de la région il comprend deux étapes:

A. Une étape de formulation politique

B. Une étape de formulation stratégique

C. Une étape de formulation tactique

D. Une étape d'analyse de situation

REP:BD

.....
4-La stratégie du plan national de prévention et du contrôle de cancer repose sur les domaines suivants:

A. La prévention

B. La détection précoce

C. Les soins de base et les soins palliatifs

D. La prise en charge diagnostique et thérapeutique

REP:ABD

.....
5-le renforcement de la couverture sanitaire mobile en milieu rurale consiste en :

A. Mise en œuvre du plan national des campagnes médicales spécialisées et mobilisation des ressources nécessaires

B. Renforcement des moyens de mobilité pour la couverture médicale mobile (CMS et EM)

C. Renforcement du plateau technique des unités hospitalières

D. Mobilisation des ressources nécessaires pour la couverture sanitaire fixe

REP:AB

.....
6-selon la stratégie ministérielle de la santé 2012/2016, l'amélioration de la prise en charge des urgences médicales consiste en :

A. Le développement du système d'information des urgences

B. L'encouragement de la recherche et de l'expertise en évaluation dans le domaine de la médecine d'urgence

C. Le renforcement des effectifs des RH exerçant dans filaires de soins médicaux d'urgences

D. Le développement des centres d'enseignement des soins d'urgences

.....

A. Le renforcement des soins de santé de base surtout en milieu urbain
B. La maîtrise des déterminants sociaux de la santé dans un cadre de collaboration
C. La revalorisation de la médecine alternative et traditionnelle
D. Et le renforcement de la formation de base des professionnels de la santé

.....

- A. Les difficultés d'accès aux soins
- B. l'importance des paiements directs des ménages
- C. La pénurie aiguë en ressources humaines
- D. L'importance des paiements de l'état

.....

A. La disponibilité des ressources suffisantes
B. La gouvernances du système national de santé
C. L'utilisation efficiente et équitable des ressources
D. La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins

.....

A. Est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires
B. Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral
C. Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial, préfectoral et les prestations hospitalières du 1er niveau seulement
D. Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial, préfectoral et les prestations hospitalières du 2ème niveau

[illegible]

A- Poches de sang humain et dérivés sanguins
B- Soins à l'étranger si manque au Maroc
C- Evacuations sanitaires inter-hospitalières
D- Actes paramédicaux

.....

A- Evacuations sanitaires inter-hospitalières
B- soins au niveau des cliniques privées
C- soins a l etranger si manque au maroc
D- soins au niveau RESSP et RH publique

.....

A-62% de la population couverte

B-63%
C-64%
D-33% AMO et 28% RAMED
REP:BD

.....
Q4. Principaux défis à la couverture sanitaire universelle
A-Défis en rapport avec le paquet essentiel de soins
B-Défis en rapport avec le financement
C-Défis en rapport avec la disponibilité des médicaments
B-Défis en rapport avec la qualité des soins
REP:ABCD

.....
Q5. CARACTERISTIQUES DE L AMO :
A-Un système obligatoire
B-Un système progressif
C-Un système à régime unique
D-Un système contributif
REP:ABD

.....
Q6. PRINCIPES DE L AMO :
A-Solidarité
B-Mutualisation des risques
C-Equité
D-Non discrimination
REP:ABD

.....
Q7. NIVEAU DE COUVERTURE DES ALD-ALC PAR L AMO-secteur public- PAR RAPPORT
A LA Tarification nationale de référence (TNR):
A-70%
B-80%
C-90%
D-100%
REP:D

.....
Q8. NIVEAU DE COUVERTURE DES SOINS AMBULATOIRES PAR L AMO-secteur privé- PAR
RAPPORT
A LA Tarification nationale de référence (TNR):
A-70%
B-80
C-90
REP:A

.....
Q9. LES ALD sont au nombre de
A-39
B-40
C-41
D-aucune
REP:C

.....
Q10. Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM)
A-établissement public, placé sous la tutelle du Ministère de l'intérieur
B-doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière

C-pour mission d'assurer l'encadrement technique de l'AMO et de veiller à la mise en place des ces outils de régulation

D-gestion des ressources financières du RAMED

REP:BCD

@@
@@
@@

Q1. Le réseau des établissements médico-sociaux est composé des:

- A. centres dits espaces« santé-jeunes;
- B. centres de rééducation physique, d'orthoptie et d'orthophonie ;
- C. centre de reeducation physique
- D. centres de soins palliatifs

REP:ABD

.....

Q2. L'offre publique de soins en mode fixe est composée des

- A. 3 réseaux
- B. 4
- C. 5

REP:B

.....

Q3. offre publique de soins en mode fixe est composée

- A. RESSP
- B. RH.
- C. REMS
- D. des structures spécialisées d'appui

REP:ABCD

.....

Q4. LeS SAMUS sont au nombre de

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

REP:C

.....

Q5. Le mode mobile comprend

- A. visites à domicile
- B. unités médicales specialisee
- C. caravanes médicales spécialisées
- d. hôpitaux locaux

REP:AC

.....

Q6. La création et l'implantation des infrastructures et des installations de santé, ainsi que des équipements biomédicaux lourds sont décidées dans le cadre de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins selon des normes et des critères relatifs notamment

- A. découpage administratif,
- B. la taille de la population
- C. l'attractivitésocio-économique
- D. accessiblité géographique

REP:BCD

.....

Q7. Normes d'implantation d un centre de sante rural 2eme niveau

- A. 7000 habitants

REP:C

Q8. criteres et normes d implantation d un centre hospitalier regional

A. 70 000 habitants
B. 200 000
C. province
D. aucun reponse

REP:D

Q9. Le nombre de lits à prévoir dans une région est calculé en fonction de la formule suivante

A. L = P X TA X TOM/365 X DMS
B. L = P X TA X DMS/365 X TOM.
C. L = P X TOM X DMS/365 X TA

L[LITS]..P[POPULATION]..TA[TAUX D ADMISSION]...

REP:B

Q10. Les instances de concertation d'un système de santé sont

A. un conseil national consultatif de la santé;
B. une commission regionale de coordination entre le secteur public et le secteur privé;
C. un comité national de veille et de sécurité sanitaires;
D. un comité national d'éthique et de recherche

REP:AC

[illegible]

Q1- la Dépense annuelle moyenne en sante/personne (en DH) en 2013

A. 1578 DHS
B. 1678
C. 1778

REP:A

Q2- pourcentage de financement de la santé selon les CNS

A. Les ressources fiscales 25.2% en 2010
B. L etat 26% en 2010
C. Menages 50.7% en 2013

REP:ABC

Q3- Budget général alloué au MS en 2015 est :

A. 12 milliards
B. 13
C. 14

REP:B

Q4- % du budget total du MS / BT de l'état en 2015

A. 5.1%
B. 5.2%
C. 5.3%

REP:C

.....
3-La commission nationale de l'offre de soins

- A. Pour mission de donner son avis sur la carte sanitaire
- B. Est présidée par le wali de la région
- C. Comprend parmi ses membres un représentant du haut commissariat au plan
- D. Toutes les propositions précédentes sont justes

REP:AC

.....
4-l'évaluation qualitative est une analyse de la qualité d'un acte de soins et de ses:

- A. Conséquences en termes de résultats et de satisfaction des patients
- B. Conséquences en termes de ressources consommées par le soin
- C. Conséquences en termes de recettes engendrées par le soin
- D. Conséquences en termes d'efficacité du soin

REP:AD

.....
5- Un réseau coordonné de soins

- A. Est une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients
- B. La prise en charge se fait au sein du même territoire
- C. Vise le renforcement de la coordination d'une prise en charge médicale multidisciplinaire
- D. Est une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients

REP:BC

.....
6- un centre de santé rural du 2ème niveau offre

- A. Les soins de consultation de médecine générale
- B. Les soins de consultation de gynécologie
- C. Les examens d'échographie obstétricale
- D. Les soins obstétricaux d'urgence de base

REP:ACD

.....
7- Les hôpitaux sont classés par catégorie selon :

- A. La capacité d'accueil
- B. le niveau d'intervention
- C. Le mode de gestion ou statut
- D. L'orientation technique ou spécialisée

REP:ABCD

.....
8- les hôpitaux de recours régional :

- A. Sont implantés au chef lieu de la région
- B. Sont le 1er niveau de référence pour les soins de santé primaire
- C. Sont dotés d'un plateau technique spécifique
- D. Leur air d'influence s'étend à l'ensemble de la région

REP:ACD

.....
9- lequel des comités suivants ne fait pas partie des instances de concertation et d'appui d'un hôpital

- A. Comité d'établissement
- B. Comité d'accréditation et démarche qualité
- C. Comité de suivi et évaluation
- D. Comité de gestion du centre hospitalier

REP:B

.....
10- la filière de soins

- A. Est un outil pour garantir la continuité et la coordination des soins

REP:ABCD

[illegible]

1- Le schéma régional de l'offre de soins (SROS) doit préciser sur la base de la carte sanitaire et des caractéristiques de la région sanitaire concernée

A. Les prévisions relatives au nombre et aux lieux d'implantation
B. Les prévisions relatives aux besoins en ressources humaines et leur réparation
C. Les prévisions relatives aux besoins en équipements biomédicaux lourd et leur réparation
D. Le projet d'établissement au niveau de chaque hôpital

REP:ABC

2- Pour la création et l'implantation d'un centre hospitalier régional ce dernier :

A. Doit desservir au moins quatre régions sanitaires
B. Doit couvrir une population minimale de 200 000 habitants
C. Doit couvrir une population minimale de 70 000 habitants
D. Toutes les propositions précédentes sont fausses

REP:D

3-le plan stratégique régional est document d'orientation des actions sanitaires de la région il comprend deux étapes:

A. Une étape de formulation politique
B. Une étape de formulation stratégique
C. Une étape de formulation tactique
D. Une étape d'analyse de situation

REP:BC

4-La stratégie du plan national de prévention et du contrôle de cancer repose sur les domaines suivants:

A. La prévention
B. La détection précoce
C. Les soins de base et les soins palliatifs
D. La prise en charge diagnostique et thérapeutique

REP:ABD

5-le renforcement de la couverture sanitaire mobile en milieu rurale consiste en :

- A. Mise en œuvre du plan national des campagnes médicales spécialisées et mobilisation des ressources nécessaires
- B. Renforcement des moyens de mobilité pour la couverture médicale mobile (CMS et EM)
- C. Renforcement du plateau technique des unités hospitalières
- D. Mobilisation des ressources nécessaires pour la couverture sanitaire fixe

REP:AB

6-selon la stratégie ministérielle de la santé 2012/2016, l'amélioration de la prise en charge des urgences médicales consiste en :

A. Le développement du système d'information des urgences

B. L'encouragement de la recherche et de l'expertise en évaluation dans le domaine de la médecine d'urgence

C. Le renforcement des effectifs des RH exerçant dans filaires de soins médicaux d'urgences

D. Le développement des centres d'enseignement des soins d'urgences

REP:ABCD

.....
7-Pour garantir l'accès équitable aux services de santé certaines actions ont été entreprises par le ministère de la santé il s'agit de :

- A. Le renforcement des soins de santé de base surtout en milieu urbain
- B. La maîtrise des déterminants sociaux de la santé dans un cadre de collaboration intersectorielle
- C. La revalorisation de la médecine alternative et traditionnelle
- D. Et le renforcement de la formation de base des professionnels de la santé

REP:BD

.....
8-les principales contraintes de la santé au Maroc sont :

- A. Les difficultés d'accès aux soins
- B. l'importance des paiements directs des ménages
- C. La pénurie aigue en ressources humaines
- D. L'importance des paiements de l'état

REP:ABC

.....
9-les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir à une couverture universelle de santé sont :

- A. La disponibilité des ressources suffisantes
- B. La gouvernances du système national de santé
- C. L'utilisation efficiente et équitable des ressources
- D. La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins

REP:BD

.....
10- Une région sanitaire

- A. Est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires
- B. Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral
- C. Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial, préfectoral et les prestations hospitalières du 1er niveau seulement
- D. Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial, préfectoral et les prestations hospitalières du 2ème niveau

REP:AD